

Síndrome mononucleósico

No todo es Epstein-Barr · Las cinco causas que hay que descartar siempre · Cuándo pedir carga viral de VIH y por qué el bazo importa

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección IV (Infectología ambulatoria)

Glosario de siglas: VEB: virus de Epstein-Barr · CMV: citomegalovirus · VHH-6: herpesvirus humano 6 · VIH: virus de la inmunodeficiencia humana · VCA: antígeno de la cápside viral · EBNA: antígeno nuclear del virus de Epstein-Barr · EA: antígeno precoz (*early antigen*) · PTLN: enfermedad linfoproliferativa postrasplante · SHF: síndrome hemofagocítico · LDH: lactato deshidrogenasa · PCR: reacción en cadena de la polimerasa.

Alcance y fuentes. Basado en la literatura de referencia sobre mononucleosis infecciosa (Luzuriaga y Sullivan, *N Engl J Med* 2010; Dunmire, *Curr Top Microbiol Immunol*), las guías de diagnóstico de infección aguda por VIH de los CDC, y las recomendaciones sobre retorno deportivo tras mononucleosis. **Este documento se centra en el enfrentamiento sindrómico ambulatorio.**

Índice

1. Qué es un síndrome mononucleósico
2. Las causas y su frecuencia relativa
3. Mononucleosis infecciosa por VEB: clínica
4. Laboratorio general
5. Anticuerpos heterófilos: qué miden y cuándo fallan
6. Serología específica de VEB
7. Las otras causas, una por una
8. El paso que no se puede omitir: descartar VIH agudo
9. Estudio escalonado del síndrome mononucleósico
10. Tratamiento de la mononucleosis
11. Complicaciones
12. Esplenomegalia, rotura esplénica y retorno deportivo
13. Situaciones especiales
14. Errores frecuentes
15. Perlas de alto rendimiento
16. Bibliografía esencial

1. Qué es un síndrome mononucleósico

Es un **cuadro clínico**, no una etiología. Se define por la combinación de:

Fiebre + odinofagia o faringitis + adenopatías (especialmente cervicales posteriores) + linfocitosis con linfocitos atípicos, con o sin esplenomegalia, hepatomegalia y exantema.

Su importancia clínica es doble: por un lado, la causa más frecuente (VEB) es benigna y autolimitada; por otro, **entre las causas está la infección aguda por VIH**, cuyo diagnóstico oportuno tiene enormes consecuencias individuales y de salud pública.

2. Las causas y su frecuencia relativa

Causa	Frecuencia aproximada	Rasgo diferenciador
Virus de Epstein-Barr (VEB)	80-90 %	Faringitis exudativa marcada, adenopatías cervicales posteriores, esplenomegalia

Causa	Frecuencia aproximada	Rasgo diferenciador
Citomegalovirus (CMV)	5-10 %	Faringitis y adenopatías más leves o ausentes; fiebre prolongada y hepatitis más prominentes. Anticuerpos heterófilos negativos
VIH agudo (síndrome retroviral agudo)	Variable	Úlceras mucosas orales o genitales, exantema maculopapular, diarrea, baja de peso, conductas de riesgo
<i>Toxoplasma gondii</i>	Poco frecuente	Adenopatías cervicales posteriores predominantes, síntomas leves; contacto con gatos o carne cruda
Otros virus	Poco frecuentes	VHH-6, adenovirus, hepatitis A, B o C en fase inicial, rubéola, parvovirus B19, dengue
No infecciosas		Reacción a fármacos (DRESS), linfoma, leucemia aguda, lupus, enfermedad de Still, enfermedad del suero

3. Mononucleosis infecciosa por VEB: clínica

- **Epidemiología:** transmisión por **saliva** ("enfermedad del beso"); **más del 90 % de los adultos ha sido infectado.** La primoinfección en la infancia suele ser asintomática; en el adolescente y adulto joven produce el cuadro clásico.
- **Incubación:** 4-6 semanas.
- **Tríada clásica:** **fiebre + faringitis + adenopatías,** presente en la mayoría.

Hallazgo	Frecuencia y comentario
Fatiga	Muy marcada y desproporcionada al resto del cuadro; puede persistir semanas o meses
Faringitis	Exudativa, con amígdalas hipertróficas; puede haber petequias en el paladar
Adenopatías	Cervicales posteriores (muy sugerentes), pero también generalizadas; epitrocleares
Fiebre	Prolongada, hasta 2 semanas
Esplenomegalia	50-60 %; máxima en la segunda a tercera semana
Hepatomegalia y hepatitis	Elevación de transaminasas en > 80 %, habitualmente leve y autolimitada; ictericia en < 10 %
Edema periorbitario	Signo de Hoagland, poco frecuente pero característico
Exantema	En < 10 % espontáneamente. En más del 80-90 % tras recibir ampicilina o amoxicilina: exantema maculopapular pruriginoso, generalizado. No es alergia y no contraindica el uso futuro de betalactámicos

El exantema tras aminopenicilinas es una de las **pistas clínicas de mayor rendimiento:** un paciente tratado como faringitis estreptocócica que desarrolla un exantema generalizado tiene mononucleosis hasta demostrar lo contrario.

4. Laboratorio general

Hallazgo	Comentario
Linfocitosis	> 50 % de linfocitos, con > 10 % de linfocitos atípicos (células de Downey); linfocitos T CD8 activados que responden a los linfocitos B infectados. Es el hallazgo hematológico característico
Elevación de transaminasas	Muy frecuente, 2-5 veces el valor normal
Trombocitopenia leve	25-50 %
Anemia hemolítica autoinmune	Poco frecuente, por crioaglutininas anti-i
LDH elevada	Frecuente
Neutropenia leve	Puede ocurrir

Los **linfocitos atípicos no son específicos de VEB:** aparecen también en CMV, VIH agudo, toxoplasmosis, hepatitis virales, rubéola, dengue y reacciones a fármacos.

5. Anticuerpos heterófilos: qué miden y cuándo fallan

- **Prueba de Paul-Bunnell / Monospot:** detecta **anticuerpos heterófilos IgM,** que aglutinan eritrocitos de otras especies. **No son anticuerpos anti-VEB:** son un fenómeno de activación policlonal de linfocitos B inducido por el virus.

- **Rendimiento:** especificidad alta (> 95 %); **sensibilidad global 70-90 % en el adulto.**
- **Cuándo da falsos negativos:**
 - **En la primera semana de enfermedad** (hasta 25 % de falsos negativos): **repetir a la semana** si la sospecha persiste.
 - **En niños menores de 4-5 años**, donde la sensibilidad es baja.
 - En cuadros mononucleósicos **no causados por VEB** — donde el resultado negativo es, de hecho, correcto.
- **Falsos positivos:** infrecuentes; descritos en linfoma, lupus, hepatitis virales, VIH agudo, malaria.

La regla operativa Un Monospot negativo **NO** descarta mononucleosis: hay que repetirlo o pasar a la serología específica de VEB. Y, sobre todo, **un Monospot negativo con cuadro mononucleósico obliga a buscar las otras causas** — empezando por **VIH agudo** y CMV.

6. Serología específica de VEB

Marcador	Aparece	Persiste	Significado
VCA IgM	Al inicio de los síntomas	4-8 semanas (a veces meses)	Infección aguda
VCA IgG	Al inicio, con máximo a las 2-4 semanas	De por vida	Infección presente o pasada
EBNA IgG	6-12 semanas después del inicio	De por vida	Infección pasada. Su ausencia en presencia de VCA IgG apoya infección reciente
EA (antígeno precoz) IgG	Fase aguda	Meses	Apoya infección aguda o reactivación; interpretación variable

Los tres patrones que hay que saber leer:

VCA IgM	VCA IgG	EBNA IgG	Interpretación
+	+	-	Infección aguda (el patrón clásico)
-	+	+	Infección pasada
-	-	-	Susceptible (nunca infectado)
-	+	-	Infección reciente (EBNA aún no positivo) o inmunosupresión

Carga viral de VEB (PCR cuantitativa): no se usa para diagnosticar la mononucleosis del inmunocompetente. **Su lugar es el paciente inmunosuprimido:** monitorización de la enfermedad linfoproliferativa postrasplante (PTLD), linfoma asociado a VEB y síndrome hemofagocítico.

7. Las otras causas, una por una

Causa	Claves clínicas	Diagnóstico
CMV	Faringitis y adenopatías leves o ausentes; fiebre prolongada e hepatitis más prominentes. Suele afectar a personas algo mayores. Anticuerpos heterófilos negativos	IgM e IgG anti-CMV con avidez de IgG si se requiere precisar el momento; PCR cuantitativa en el inmunosuprimido
VIH agudo	Úlceras mucosas orales, genitales o anales (muy sugerentes), exantema maculopapular , fiebre, faringitis no exudativa , adenopatías, mialgias, diarrea, baja de peso. Antecedente de exposición 2-4 semanas antes	CARGA VIRAL (ARN) de VIH — la serología puede ser negativa. Ver sección 8
<i>Toxoplasma gondii</i>	Adenopatías cervicales posteriores como manifestación dominante, con síntomas generales leves; fatiga prolongada. Contacto con gatos, carne cruda o mal cocida, verduras mal lavadas	IgM e IgG anti-Toxoplasma** con avidez de IgG
VHH-6	Cuadro similar; más relevante en el inmunosuprimido	PCR (cuidado con el VHH-6 integrado en el cromosoma , que da cargas altas persistentes sin enfermedad)
Hepatitis A, B o C	Predominio de hepatitis con transaminasas muy elevadas	Serologías específicas

Causa	Claves clínicas	Diagnóstico
Rubéola	Exantema, adenopatías retroauriculares y occipitales , artralgias	Serología
Adenovirus	Faringoconjuntivitis, fiebre	PCR
Reacción a fármacos (DRESS)	Exantema extenso , fiebre, eosinofilia , adenopatías, compromiso hepático y renal, 2-8 semanas tras el fármaco (anticonvulsivantes, alopurinol, sulfas, antituberculosos)	Clínico; suspender el fármaco
Linfoma o leucemia aguda	Síntomas B, adenopatías firmes o duras y persistentes, citopenias, LDH muy elevada, blastos en el frotis	Frotis, biopsia ganglionar, mielograma

8. El paso que no se puede omitir: descartar VIH agudo

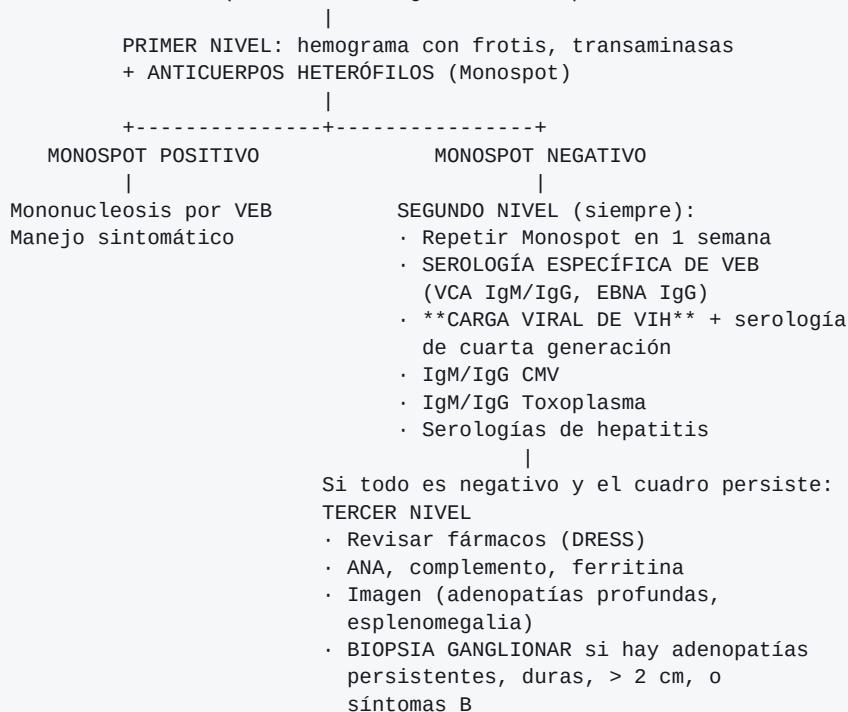
Todo síndrome mononucleósico obliga a considerar y descartar la infección aguda por VIH.

- La serología estándar puede ser **NEGATIVA** en la fase aguda: los anticuerpos aparecen a las 3-4 semanas, mientras que el **ARN viral es detectable a los ~10 días** y el **antígeno p24 a los ~14-20 días**. - Por lo tanto, ante sospecha de infección aguda, hay que solicitar **carga viral (ARN) de VIH**, además del inmunoensayo de cuarta generación. - **Las cargas virales en la infección aguda son muy altas** (típicamente > 100.000 copias/mL): un valor bajo aislado debe hacer sospechar un falso positivo y repetirse. - **Es el momento de mayor contagiosidad** de toda la historia natural del VIH, por la viremia masiva: el diagnóstico tiene un impacto directo en la transmisión. - **El diagnóstico precoz permite iniciar terapia antirretroviral de inmediato**, lo que mejora el pronóstico inmunológico y previene la transmisión. - En Chile, el diagnóstico de VIH requiere **consentimiento informado y consejería** (Ley 19.779): ver el documento de Virología diagnóstica.

Los elementos que más deben aumentar la sospecha: **úlceras mucosas**, exantema maculopapular troncal, diarrea, baja de peso, y **Monospot negativo** en un cuadro compatible.

9. Estudio escalonado del síndrome mononucleósico

Cuadro mononucleósico (fiebre + faringitis + adenopatías + linfocitosis atípica)



10. Tratamiento de la mononucleosis

- **Es sintomático:** reposo relativo, hidratación, analgésicos y antipiréticos (paracetamol, antiinflamatorios no esteroidales).

- Los antivirales (aciclovir) **NO están indicados**: reducen la eliminación viral orofaríngea pero **no modifican los síntomas ni el curso clínico**.
- Los corticoides **NO se usan de rutina**. Sus indicaciones acotadas son:
 - **Obstrucción de la vía aérea** por hipertrofia amigdalina o edema faríngeo (la indicación más clara).
 - **Anemia hemolítica autoinmune o trombocitopenia grave**.
 - Complicaciones neurológicas o miocarditis.
 - **No se usan para acortar la fatiga ni la fiebre**, y hay preocupación teórica por la inmunosupresión en una infección viral aguda.
- Evitar **ampicilina y amoxicilina** cuando se sospecha mononucleosis, por el exantema.
- **Anticipar el curso al paciente**: la fiebre cede en 1-2 semanas, la faringitis en 1-2 semanas, las adenopatías en 2-4 semanas, y **la fatiga puede persistir 1-3 meses o más**. Explicarlo evita reconsultas y estudios innecesarios.
- **No se requiere aislamiento**: la transmisión requiere contacto estrecho con saliva.

11. Complicaciones

Complicación	Comentario
Obstrucción de la vía aérea	Por hipertrofia amigdalina masiva; es la indicación más clara de corticoides , y ocasionalmente requiere manejo de vía aérea
Rotura esplénica	Rara (0,1-0,5 %) pero potencialmente mortal . Puede ser espontánea o traumática. Máximo riesgo entre la semana 2 y 3
Hepatitis	Casi siempre leve; la falla hepática aguda es excepcional
Citopenias inmunes	Anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia, neutropenia
Neurológicas	Meningitis aséptica, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré , parálisis de pares craneales, síndrome de Alicia en el país de las maravillas (metamorfopsia)
Miocarditis, pericarditis	Infrecuentes
Síndrome hemofagocítico	Grave; sospechar ante fiebre persistente, citopenias, ferritina muy elevada , esplenomegalia, hipertrigliceridemia
Sobreinfección bacteriana	Faringitis estreptocócica concomitante, absceso periamigdalino
Fatiga prolongada	Frecuente; puede durar meses

Asociaciones a largo plazo del VEB: linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin, carcinoma nasofaríngeo, linfoma del sistema nervioso central en personas con VIH, enfermedad linfoproliferativa postrasplante, leiomiomasarcomas en inmunosuprimidos, y asociación epidemiológica con la **esclerosis múltiple**.

12. Esplenomegalia, rotura esplénica y retorno deportivo

Este punto tiene relevancia práctica concreta, porque afecta a la población más frecuentemente comprometida (adolescentes y adultos jóvenes).

- La **esplenomegalia** está presente en el **50-60 %** de los casos y alcanza su máximo entre la **segunda y la tercera semana**.
- El **examen físico es poco sensible** para detectarla: la ecografía la identifica en una proporción mucho mayor de pacientes.
- La **rotura esplénica** es rara pero puede ser fatal, y ocurre predominantemente en las **primeras 3-4 semanas**.

Recomendación práctica de retorno deportivo: - Evitar deportes de contacto, levantamiento de pesas y actividad física intensa durante al menos 3-4 semanas desde el inicio de los síntomas. - En deportes de contacto o de colisión, muchos protocolos extienden la restricción a 4 semanas o más, y algunos exigen la resolución clínica y, cuando hay dudas, la normalización ecográfica. - La ecografía de rutina **no se recomienda** para decidir el retorno en todos los pacientes, porque el tamaño esplénico normal tiene amplia variabilidad individual; se usa en casos seleccionados. - **Advertir sobre los síntomas de rotura**: dolor abdominal súbito en hipocondrio izquierdo, dolor referido al hombro izquierdo (**signo de Kehr**), mareo o síncope -> **consultar de inmediato**.

13. Situaciones especiales

Situación	Consideraciones
Embarazo	La primoinfección por CMV y por Toxoplasma en el embarazo tiene consecuencias fetales; ante un cuadro mononucleósico en una embarazada, el estudio serológico con avidez de IgG es prioritario, y se requiere evaluación obstétrica especializada
Inmunosupresión y trasplante	El VEB causa enfermedad linfoproliferativa postrasplante (PTLD) ; se monitoriza con carga viral , y el manejo incluye reducción de la inmunosupresión y rituximab. El CMV requiere monitorización propia
Personas con VIH	Considerar además leucoplasia vellosa oral (VEB) y linfomas asociados
Fiebre prolongada sin diagnóstico	El síndrome mononucleósico prolongado sin causa identificada entra en el diferencial de la fiebre de origen desconocido
Adenopatía persistente	Una adenopatía que no regresa en 4-6 semanas, dura, > 2 cm, supraclavicular o con síntomas B, requiere biopsia

14. Errores frecuentes

- Tratar como faringitis estreptocócica y provocar el exantema por aminopenicilinas. - Interpretar ese exantema como **alergia a penicilina** y etiquetar al paciente de por vida. - **Descartar mononucleosis por un Monospot negativo**, sin repetirlo ni pasar a serología específica. - **No descartar VIH agudo** ante un cuadro mononucleósico, especialmente con Monospot negativo. - **Pedir sólo serología de VIH** en la sospecha de infección aguda, sin **carga viral**. - **Dar aciclovir** para la mononucleosis. - **Dar corticoides de rutina** para acortar los síntomas. - **No advertir sobre la restricción deportiva** y el riesgo de rotura esplénica. - **No anticipar la duración de la fatiga**, lo que genera estudios y consultas innecesarias. - **No biopsiar una adenopatía persistente** con características de alarma. - **Olvidar los fármacos** como causa (DRESS) ante fiebre, exantema, adenopatías y eosinofilia.

15. Perlas de alto rendimiento

- El síndrome mononucleósico es un cuadro clínico, no una etiología: VEB explica el 80-90 %, pero no todo.
- Exantema tras amoxicilina en una "faringitis" = mononucleosis, y no es alergia.
- Adenopatías cervicales POSTERIORES y fatiga desproporcionada orientan a VEB.
- El Monospot puede ser negativo en la primera semana y en niños pequeños: repetir o pasar a serología específica.
- VCA IgM+ / VCA IgG+ / EBNA IgG- = infección aguda. EBNA IgG+ = infección pasada.
- CMV: faringitis y adenopatías leves, hepatitis y fiebre prolongada, Monospot negativo.
- Toxoplasma: adenopatías cervicales posteriores dominantes con síntomas leves.
- Todo síndrome mononucleósico obliga a descartar VIH agudo con CARGA VIRAL, porque la serología puede ser negativa — y es el momento de mayor contagiosidad.
- Úlceras mucosas + exantema + fiebre en un adulto joven = VIH agudo hasta demostrar lo contrario.
- El tratamiento es sintomático; el aciclovir no sirve y los corticoides se reservan para la obstrucción de la vía aérea y las citopenias graves.
- Restringir deportes de contacto 3-4 semanas por el riesgo de rotura esplénica; advertir el signo de Kehr.
- La fatiga puede durar meses: anticiparlo es parte del tratamiento.
- Adenopatía persistente, dura, > 2 cm o con síntomas B: biopsiar.

16. Bibliografía esencial

- Luzuriaga K, Sullivan JL. Infectious mononucleosis. *N Engl J Med*. 2010;362:1993-2000.
- Dunmire SK, Verghese PS, Balfour HH. Primary Epstein-Barr virus infection. *J Clin Virol*. 2018;102:84-92.
- Hoagland RJ. Infectious mononucleosis. *Prim Care*. 1975;2:295-307.
- Ebell MH, Call M, Shinholser J, Gardner J. Does this patient have infectious mononucleosis? The Rational Clinical Examination systematic review. *JAMA*. 2016;315:1502-9.
- Centers for Disease Control and Prevention y Association of Public Health Laboratories. *Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection: Updated Recommendations*. 2014 y actualizaciones.
- Putukian M, O'Connor FG, Stricker P, et al. Mononucleosis and athletic participation: an evidence-based subject review. *Clin J Sport Med*. 2008;18:309-15.

- Cohen JI. Epstein-Barr virus infection. *N Engl J Med*. 2000;343:481-92.